

**Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Faculté de médecine de Constantine**

Travail dirigé
4^{ème} année médecine

**Examen clinique en proctologie
Et
Conduite à tenir devant une douleur Anale**

Dr Abderraouf BATAICHE
Maitre-assistant en chirurgie générale
EH. Didouche Mourad

Module de gastro-entérologie

Année universitaire 2025 – 2026

Plan :

- I- Introduction
- II- Intérêt de la question
- III- Objectifs pédagogiques
- IV- Rappel Anatomique
- V- Examen clinique en proctologie
- VI- Etiologie et Traitement
- VII- Conclusion
- VIII- Références bibliographique

I- INTRODUCTION

La douleur anale est une manifestation clinique pouvant être aigue ou chronique évoquant plusieurs maladies, nécessitant un examen clinique proctologique soigneux et une prise en charge étiologique adéquate pouvant être conduite seulement par le médecin généraliste.

II- INTERET DE LA QUESTION

La douleur anale est un motif fréquent de consultation.

La difficulté de l'examen clinique proctologique liée surtout à la gêne et à la pudeur.

Représente la manifestation clinique de plusieurs pathologies

Peut-être traitée seulement par le médecin généraliste en absence d'indication chirurgicale

III- OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Savoir interroger un malade ayant une douleur anal

savoir-faire l'examen clinique proctologique

Connaitre les différentes étiologies

Adapté une conduite thérapeutique

IV- RAPPEL ANATOMIQUE

L'anus se compose d'une marge anale suivie d'un canal anal qui comprend un système sphinctérien associant, 1) des fibres circulaires : le sphincter anal interne et le sphincter anal externe de l'anus 2) des fibres longitudinales : le muscle longitudinal

Le sphincter anal interne (SAI) est un muscle lisse d'environ 3 cm de haut. Il s'agit d'un prolongement de la couche musculaire lisse du rectum. Le sphincter anal externe (SAE) est un muscle strié comprenant trois portions (profonde, superficielle et sous cutanée) disposées le long du canal anal de haut en bas.

Les hémorroïdes sont des formations vasculaires physiologiques qui proviennent majoritairement de l'artère rectale supérieure. Il est possible de distinguer les hémorroïdes externes en regard du sphincter externe au niveau de la marge anale et les hémorroïdes internes en regard du sphincter interne proche de la ligne pectinée.

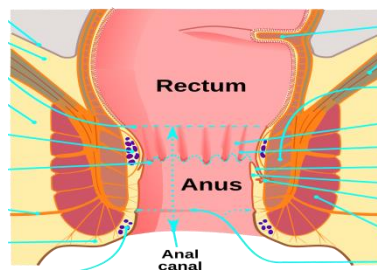


Figure 1 : anatomie du canal anal

V- EXAMEN CLINIQUE EN PROCTOLOGIE

1. Interrogatoire

Antécédents médicaux (maladie inflammatoire +++, cancer rectal)
Antécédents proctologiques (affection et/ou chirurgie Ano rectale)
Antécédents gynécologiques (grossesse, accouchement, chirurgie pelvienne)
prise médicamenteuse
Profil du transit intestinal (diarrhée, constipation)
Le symptôme précis et ses caractéristiques
Autres symptomatologies fonctionnelles (prurit, saignement, prolapsus, écoulement,...)
Ancienneté de la maladie (aigue ou chronique)
Maladies sexuellement transmissibles

2. Examen physique

But: Examiner votre périnée, votre anus et éventuellement votre rectum pour rechercher une anomalie Ano rectale afin d'expliquer des symptômes, poser un diagnostic et proposer un traitement adapté.

Préparation: il faut expliquer au malade le geste à faire et la raison pour laquelle on va le faire et avoir son accord. Malade dévêtue en bas et mis sur une table d'examen.

Position : genupectorale, les avant-bras pliés et posés sur la table (fig. 2), soit en décubitus latérale gauche, les genoux fléchis et remontés vers la poitrine (fig. 3).

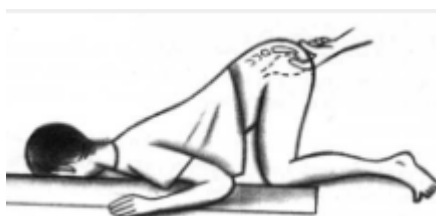


Figure2: position genupectorale



Figure 3: position décubitus latéral gauche

Inspection : de la marge anale et la région périnéale avec déplissement des plis radiés a la recherche d'une masse, tuméfaction, ulcération, orifice, un écoulement (sanguin ou purulent), un prolapsus et une lésion cutanée.

Palpation : des bords de l'anوس et de la région périnéale à la recherche d'une masse, d'une zone douloureuse tuméfiée ou indurée.

Toucher rectale : introduction douce dans l'anوس et jusqu'au rectum de l'index du médecin après lubrification du doigt ganté. Cet examen permet de rechercher une tuméfaction, une douleur localisée, une induration, une masse, un écoulement (sanguin ou louche) et apprécier la tonicité du sphincter anal.

Anuscopie :

Examen simple, rapide, peu invasif, réalisé le plus souvent à vif, qui permet d'explorer le canal anal et la partie terminale du rectum.

- Matériel : anoscope plastique ou métallique court avec un mandrin amovible (figure 4).
- Lubrification du matériel pour faciliter l'introduction
- Introduction douce de l'anoscope dans le canal anal, le mandrin est retirée une fois l'instrument en place.
- Exploration de la muqueuse anale (hémorroïde interne (figure 5), ulcération, masse)
- Possible de faire une biopsie si lésion accessible (légère saignement de 24h environ)
- Retrait doux de l'anoscope.

Remarque : examen a évité si douleur intense ou sténose anale.

Réalisé sous anesthésie locale ou générale si : spasme anale sévère, anomalie anatomique ou une anxiété extrême du malade.



Figure 4 : anoscope



Figure 5 : vue d'anuscopie
(Hémorroïde interne)

VI- ETIOLOGIE et TRAITEMENT

1. Douleur aigue :

1.1. Maladie et Thrombose Hémorroïdaire :

Définition : l'hémorroïde est une dilatation des veines hémorroïdaires formant des varices au niveau de l'anus (fig. 6). La thrombose hémorroïdaire est la constitution à l'intérieur du paquet hémorroïdaire d'un thrombus sanguin (fig. 7).



Figure 6 : hémorroïde externe



Figure 7 : thrombose hémorroïdaire

Etiopathogénie : l'alcool, les épices, le stress, la sédentarité prolongée, la constipation, la grossesse et l'accouchement.

Clinique :

- Maladie hémorroïdaire : saignement, prurit, prolapsus et douleur.
- Thrombose hémorroïdaire: Douleur aigue brutal. A l'examen proctologique un ou plusieurs tuméfaction bleutés sous la muqueuse anale au niveau de la marge, douloureuse au toucher ou à la pression.

Traitement :

Le traitement de la maladie hémorroïdaire est basé sur :

- Règles hygiéno-diététique :

La pratique d'activité physique

Evité la sédentarité, les épices, l'alcool, le café et la position assise prolongée

Alimentation riche en fibre jusqu'à 3 mois

- Traitement médical : (cure de 7 à 10 jours)

Laxatifs : cure courte lors d'une crise hémorroïdaire ou longue dans un but préventif

Ex : FORLAX 10g sachet ×1 a 2/jour (associer aux mesures d'hygiène)

Antalgique: classe I, pour diminuer la douleur d'une crise hémorroïdaire.

Ex : Paracétamol Comprimé 1g ×3/jour

Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) : à éviter chez la femme qui allaite et la femme enceinte jusqu'au 6eme mois et contre indiquer après.

Ex : IBUPROFENE comprimé 400mg ×1 a 3/jour pendant une courte durée (5 a 7 jours)

Topiques locaux : suppositoires, crèmes et pommades. Peuvent associer des corticoïdes locaux et/ou des anesthésiques, des agents myorelaxants, des carragénates et tous des cicatrisants. Recommandés si manifestation aigue, Pas de bénéfice à long terme et ne prévient pas la thrombose hémorroïdaire externe.

Ex : TITANOREÏNE crème tube 40g, 1 application de crème, matin et soir et après chaque selle, sans dépasser 4 applications par jour.

Veinotonique : agit sur l'origine vasculaire. en cure courte des crises hémorroïdaires, peuvent être utilisées chez la femme enceinte, ne prévient pas la thrombose hémorroïdaires externe

Ex : DAFLON comprimé 500mg ou 1000mg
6 comprimés à 500 mg ou 3 comprimés à 1000 mg par jour les 4 premiers jours
puis 4 comprimés à 500 mg ou 2 comprimés à 1000 mg par jour pendant 3 jours.

- Traitement instrumental :

Photocoagulation infrarouge : 2 à 4 séances espacées de 4 semaines

Ligature élastique : 1cm au-dessus de la ligne pectinée dans le but d'obtenir un escarce cicatrisant en 3 semaines.

La cryothérapie : vise à obtenir une nécrose du tissu hémorroïdaire par application de froid. Utiliser seule ou associer à la ligature élastique.

Injection sclérosante : abandonné

- Traitement chirurgical :

Les principales techniques sont : hémorroïdectomie, hémorroïdopexie et ligature hémorroïdale S/Doppler

Le traitement de la thrombose hémorroïdaire est basé sur :

- Traitement médical : Antalgique, AINS et Topiques locaux contenant un corticoïde
- L'excision après une anesthésie locale consiste à enlever la peau en regard de la thrombose pour en extraire le(s) caillot(s). Cela implique des soins locaux (antiseptiques et pommade dite « cicatrisante »). Cette petite intervention est réalisée en cas d'échec du traitement médical mais il existe un risque de saignement après le geste.
- Le traitement chirurgical est réservé aux échecs des traitements précédents.

Remarque : Les mesures d'hygiène ne préviennent pas la survenue de thrombose

1.2. Fissure anale :

Définition : c'est une ulcération de l'anoderme du canal anal.

Etiopathogénie : constipation, hypertonie sphinctérienne, ischémie locale .

Clinique : Douleur anal a type de déchirure déclenchée par la défécation

Le diagnostic est fait à l'inspection de la marge anale en dépliant les plis radiés de l'anus (figure 8,9). Le toucher rectal retrouve le plus souvent une hypertonie anale.

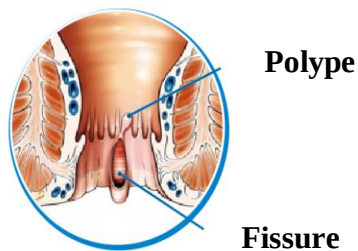


Figure 8 : fissure anale schématique



Figure 9 : fissure anale

Les différentes formes de fissure sont :

- Fissure aiguë
- Fissure chronique
- Fissure abcédée
- Fissure hyperalgique
- Fissure du post partum

Traitement :

- Traitement standard (non spécifique) :

Régularisation du transit : alimentation riche en fibre et laxatifs (osmotique ou mucilage)

Topiques locaux : pour but de lubrification permettant la cicatrisation

Antalgique : en cas de douleur

AINS : si douleur et en absence d'un abcès

- Traitement moderne :

Sphincterotomie chimique : dérivés nitrés, toxine botulique et les inhibiteurs calciques

But : lever le spasme sphinctérien et permettre la cicatrisation

- Traitement chirurgicale :

Indication : fissure anal chronique et hyperalgique

Technique : fissurectomie (resection de la fissure) + leiomyotomie (sphinctérotomie partielle)
+ anoplastie (suture de la muqueuse à la peau) (fig. 10)

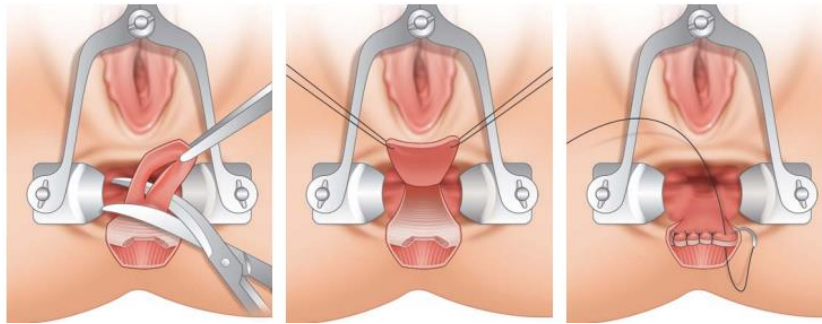


Figure 10 : fissurectomie + anoplastie

1.3. Suppuration et Fistule anale :

Définition : la fistule anorectale est une communication anormale entre le canal anal d'une part et la peau périanale d'autre part (Fig. 11).

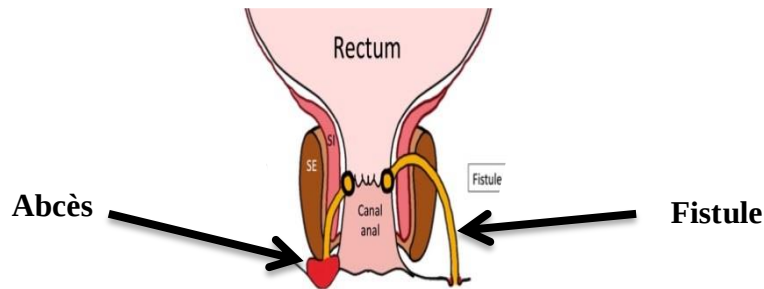


Figure 11 : fistule anale schématique

Etiopathogénie : infection initiale d'une glande anale d'Hermann et Des fosses s'ouvrant à la partie moyenne du canal anal.

Clinique : se manifeste le plus souvent par des écoulement purulent et des douleurs surtout si un abcès est associés.

Traitement : est uniquement chirurgical, la fistulectomie.

Si abcès associés : traitement antibiotique avec ou sans drainage et mise à plat.

1.4. Autres :

Traumatisme

infection

maladie inflammatoire :

Maladie de crohn ++, RCH, proctite

médicaments :

Médicaments causant une constipation (antidépresseur, morphinique,...)

Médicaments causant une diarrhée qui provoque une irritation de la muqueuse (antibiotique, AINS)

Maladie sexuellement transmissible : par infection ou par traumatisme

2. Douleur chronique

Elle est définie comme une douleur localisée à l'anus ou la région périanale qui dure plus de 3 mois d'une façon continue ou intermittente.

2.1.Syndrome du muscle élévateur de l'anus :

Le muscle élévateur de l'anus est un muscle large et mince qui forme la majeure partie du diaphragme pelvien. Il soutient les organes pelviens (rectum, vagin, vessie) et joue un rôle dans la continence et la défécation.

Définition :

C'est une affection douloureuse chronique causée par un spasme des muscles du plancher pelvien

Symptômes :

Douleur sourde, persistante ou intermittente située dans le rectum, le périnée ou la région pelvienne, due à une hypertonie, un spasme ou une hypersensibilité du muscle élévateur de l'anus.

Quasi quotidienne d'une durée de quelques minutes à quelques heures.

Aggravée à la position assise après des efforts ou des selles, soulagée à la position couchée.

Diagnostic :

Interrogatoire détaillé
Douleur à la palpation avec tension musculaire
Absence de lésion organique

Traitement :

Mesures hygiéno-diététiques (lutter contre la constipation, éviter les pousses excessives au toilettes et avoir une posture adéquate)
Antalgique + antidépresseur tricyclique (soulage la douleur neurologique)
Rééducation périnéale et kinésithérapie pelvienne

2.2. Proctalgie fugace :

Définition :

Douleur rectale aiguë, brève et récurrente, sans cause organique identifiable, du plus probable à un spasme du muscle pubo rectal.

Symptômes :

Douleur profonde dans l'anus ou le rectum
Durée brève, 20 minute au maximum
Episodes sporadiques et espacés
Nocturne et très intense (crampe, déchirure)

Diagnostic :

Pas d'examen de certitude
Douleur typique
Examen proctologique normal entre les crises
Eliminer une autre lésion

Traitement :

Rassurer le patient (pathologie bénigne)
Bain de siège
Massage doux du périnée
Si épisodes fréquentes : anxiolytique et myorelaxant

2.3. Coccygodynie**Définition :**

C'est une douleur localisée au niveau du coccyx (dernier os de la colonne vertébrale) qui peut être due à : un traumatisme, une position assise prolongée, l'accouchement ou une tumeur.

Symptôme :

Douleur du bas du dos
Aggraver à la position assise et soulager en se levant

Diagnostic :

Interrogatoire (traumatisme, accouchement,)
Douleur à la palpation du coccyx
Imagerie (radiographie, TDM, IRM selon l'étiologie suspecter)

Traitement :

Coussin antidouleur
Eviter la position assise
Kinésithérapie
Traitement plus invasifs (neurostimulation, infiltration de corticoïde voir la chirurgie)

2.4. Névralgie pudendale :

Définition :

La névralgie pudendale est une affection douloureuse chronique causée par une irritation, une compression ou un dysfonctionnement du nerf pudental, un nerf majeur qui innerve la région périnéale (entre les organes génitaux et l'anus)

Symptôme :

Douleur brûlante, dans le périnée, le rectum et les organes génitaux externes.
Aggravation en position assise
Dysfonction génito-sphinctériennes

Diagnostic :

Examen clinique (symptômes typiques)
Imagerie (IRM pelvienne, échographie endovaginale/rectale)

Traitement :

Eviter la position assise prolongée
Kinésithérapie
Antalgique, antidépresseur, infiltration locale de corticoïde
Neurostimulation
Chirurgie de décompression

2.5. Autres :

Tumeur
Hémorroïde
Fissure anale
Fistule Ano rectale
Infection

VII- CONCLUSION

La douleur anale est un symptôme cardinal en proctologie. Un interrogatoire détaillé et la réalisation d'un examen clinique proctologique permettent rapidement de faire le diagnostic différentiel entre les différentes pathologies anorectales les plus fréquentes et la prise en charge primaire peut facilement être réalisée par le médecin généraliste.

VIII- REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE

- (1) O. Pittet et al, Douleur anale aiguë, Rev Med Suisse 2014; 10 : 555-60
- (2) Nono, M. H. Conduite à tenir devant une douleur anale. Acta Endoscopica, 2005 ; 35 : 537-539
- (3) Pierre DALIBON, La maladie hémorroïdaire, Elsevier Masson 2019 ; 58 : 46-50

- (4) Laurent Siproudhis & Thierry Higuero, Traitements de la maladie hémorroïdaire, société nationale française de colo proctologie, 2017.
- (5) Anne Laurain & Laurent Abramowitz, Fissure anale : d'abord corriger la constipation, la revue du praticien, 2019 ; 33 : 170-2
- (6) Higuero, T. Mise au point sur la prise en charge des fissures anales. Journal de Chirurgie Viscérale, 2015 ; 152, 35–42.
- (7) Anne-Laure Tarrerias, La fistule anale cryptogénique, FMC-HGE, 2013 ; 10 :91-100